

Кетамин

Неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов · диссоциативный анестетик

ФОРМА ВЫПУСКА

5 % · 2 мл = **100 мг**
50 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Блокада открытого канала NMDA-рецептора → функциональное разобщение коры и лимбической системы. Торможение обратного захвата катехоламинов: рост ЧСС, АД и потребности миокарда в кислороде (MVO_2). Прямой отрицательный инотропный эффект скрыт до истощения эндогенных депо.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Выраженная боль (в т.ч. при переломе таза после введения фентанила)	0,5 мг/кг	в/в медленно
Crush-синдром, открытые переломы (после опиоидов)	0,5-2 мг/кг	в/в болюсно
Индукция ДП (прил. 4, ШКГ > 4)	диазепам 10 мг и кетамин 1-2 мг/кг	в/в
Премедикация к кардиоверсии	1-2 мг/кг	в/в болюс
Отсутствие венозного доступа	2-4 мг/кг	в/м
Индукция при ЧМТ	запрещено (стр. 17)	

Пример расчёта дозы. $0,5 \text{ мг/кг} = 0,01 \text{ мл/кг} \cdot 70 \text{ кг} \rightarrow 35 \text{ мг} = 0,7 \text{ мл} \cdot 1-2 \text{ мг/кг} \rightarrow 1,4-2,8 \text{ мл}$

НАСОС 31-Р введение кетамина с помощью шприцевого дозатора не регламентировано

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Индукция при ЧМТ — прямой запрет приказа
- Неконтролируемая артериальная гипертензия, критический аортальный стеноз, тиреотоксикоз, острый коронарный синдром — риск ишемии из-за неконтролируемого роста MVO_2
- Затяжной геморрагический шок или надпочечниковая недостаточность — истощение запасов катехоламинов; препарат перестаёт поддерживать давление и вызывает прямое угнетение миокарда

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Пропофол, мидазолам, барбитураты и высокие дозы фентанила вызывают аддитивное подавление дыхательного центра вплоть до апноэ. Одновременная вазодилатация может привести к глубокой гипотонии
- Для профилактики галлюцинаторного синдрома («психоделического выхода») у взрослых бензодиазепины вводятся превентивно. Попытка купировать уже развившийся делирий введением диазепама постфактум малоэффективна